נקז חזה בטראומה ובמלר"ד

שלומית אטלו
ראש צוות טראומה
הדסה עין כרם

אינדיקציות להכנסת נקז חזה

- חזה אוויר בלחץ (Tension Pneumothorax)
- חזה דם (Hemothorax)
- חזה אוויר פתוח
- חזה אוויר, על פי שיקול דעת רפואי
- דום לב בטראומה כתוצאה מחבלה קהה (נקזים דו"צ לפני פתיחת חזה)
- דום לב בטראומה כתוצאה מחבלה חודרת, על פי שיקול דעת רפואי
- מטופל מונשם עם חזה אוויר

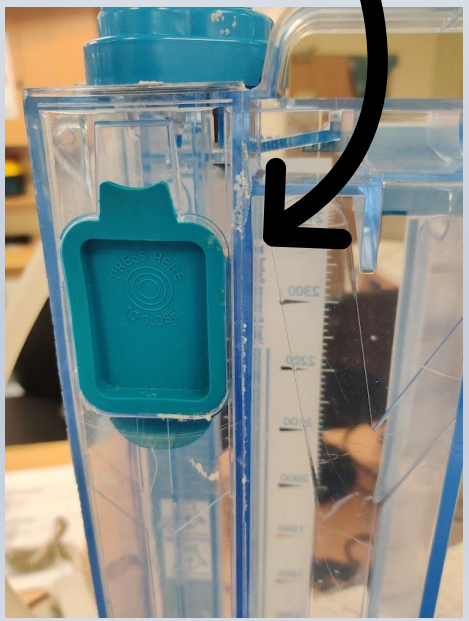
ציוד להכנסת נקז חזה

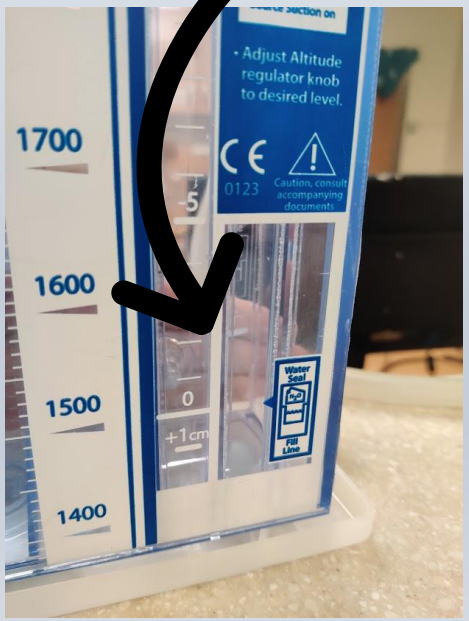
- חלוק סטרילי
- כפפות סטריליות (שני סטים)
- כלורקסידין על בסיס אלכוהול
- ערכת קומבו (ערכת כלים סטריליים)
- לידוקאין
- מזרק 10 מ"ל
- מחט שאיבה ומחט הזרקה
- להב / סקלפל
- נקז חזה
- המרסון (כחול - בודד, ירוק - כפול)
- בקבוק סליין סטרילי למילוי ההמרסון
- צינור סקשיין
- תפר משי 1.0
- 2 מדבקות לקיבוע (טגדרם)
- גאזה סטרילית
- ג'לונט

חשוב מאוד!! יש לוודא הכנת ציוד טרם תחילת ביצוע הפרוצדורה

תפעול המרסון לקראת שימוש

- יש למלא בסליין (בקבוק 160 מ"ל) דרך הפתח בחלקו האחורי של ההמרסון עד לקו ה - 0 המסומן מלפנים





- יש לחבר את צינורית הסקשיין לחיבור המתואר בתמונה

הכנה לקראת הכנסת נקז

- במידה ולמטופל יש חזה אוויר בלחץ, יש לשקול הכנסת מחט לחזה (NEEDLE) טרם הכנסת נקז חזה לייצוב המודינמי של המטופל
- יש לתת משככי כאבים סיסטמיים בנוסף להרדמה מקומית, בדר"כ מדובר על מורפין / פנטניל
- יש לוודא כי קיימת מערכת סקשיין תקינה, נקייה ומוכנה לשימוש

תהליך הכנסת נקז חזה

- יש לפתוח את הציוד באופן סטרילי
- לוודא חיטוי אזור הכנסת הנקז טרם תחילת הכנסת נקז החזה למניעת זיהומים עתידיים
- סרטון הדגמה להכנסת נקז חזה: https://www.youtube.com/watch?v=1Ak9sNMy0LQ

דגשים לאחר הכנסת נקז החזה

- יש לוודא הדבקה טובה בחיבור בין נקז החזה וצנרת ההמרסון וכן הדבקה לבית החזה בכדי למנוע התנתקות / שליפת הנקז והחמרה של מצב המטופל
- ביצוע צילום חזה חוזר לווידוא מצב הריאה ומיקום נקז החזה
- בחזה דם (המוטורקס), יש לעקוב אחר כמות הדם שיוצאת להמרסון בזמן הכנסת הנקז וכל שעה ב-4 שעות הראשונות ולתעד בכדי לזהות חזה דם מאסיבי. במצב של חזה דם מאסיבי יש לשקול מתן מנות דם וטיפול בחדר ניתוח במידת הצורך
- המרסון מונע חדירת אוויר לריאה ולכן לקראת שינוע המטופל, יש לנתק את ההמרסון מהסקשיין, **אין** לחסום את צינור הנקז ויש לוודא כי ההמרסון נמצא נמוך מגובה הלב

בהצלחה!

תמיד פה לכל שאלה ☺